

यदि आप पेल्विक अंग प्रोलैप्स (POP) की सर्जरी पर विचार कर रही हैं, तो आपको और आपके सर्जन को मिलकर कुछ निर्णय लेने होंगे। अक्सर कोई एक “सही” उत्तर नहीं होता — सबसे अच्छी योजना आपकी शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। यह पत्रक मुख्य निर्णयों की जानकारी देता है।

## मुख्य निर्णय

- **मरम्मत बनाम बंद करना** — सपोर्ट को फिर से बनाना (reconstructive) और योनि को खुला रखना, या योनि को बंद करना (colpocleisis) यदि आप योनि संभोग नहीं चाहती।
- **रास्ता** — योनि के रास्ते, या पेट में छोटे छेद/robotic सर्जरी से।
- **गर्भाशय** — इसे निकालना (hysterectomy) या गर्भाशय-संरक्षित suspension (hysteropexy) से रखना।
- **सपोर्ट सामग्री** — अपना खुद का ऊतक (native repair), biological graft, या mesh (sacrocolpopexy में पेट का mesh)।
- **मूत्र रिसाव** — अभी anti-leakage प्रक्रिया जोड़नी है या नहीं (नीचे देखें)।

## छुपे हुए रिसाव के बारे में

कभी-कभी बड़ा प्रोलैप्स तनाव मूत्र असंयम (SUI) को **छुपा** लेता है, जो प्रोलैप्स ठीक होने के बाद ही दिखता है (“occult” SUI)। आपकी टीम इसकी जाँच कर सकती है और चर्चा कर सकती है कि sling एक साथ लगाएँ या बाद में।

### शब्दों को समझें

#### Reconstructive

सपोर्ट फिर से बनाना और योनि को कार्यशील रखना।

#### Obliterative

योनि को बंद करना (colpocleisis) — बहुत टिकाऊ, संभोग समाप्त।

#### Hysteropexy

गर्भाशय-संरक्षित suspension (गर्भाशय रहता है)।

#### Native-tissue repair

केवल अपने ऊतक से मरम्मत, कोई graft नहीं।

#### Occult SUI

छुपा हुआ तनाव रिसाव जो प्रोलैप्स ठीक होने पर दिखता है।

#### Recurrence

समय के साथ प्रोलैप्स वापस आने की संभावना।

**मैं कैसे चुनूँ?** अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार — टिकाऊपन, ठीक होने का समय, गर्भाशय रखना, यौन गतिविधि, और mesh के बारे में आपकी राय। आपका सर्जन आपकी शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य के अनुसार सुझाव देगा; “सबसे अच्छा” विकल्प वह है जो स्पष्ट चर्चा के बाद आपके लक्ष्यों से मेल खाए।

### अपने सर्जन से पूछने वाले प्रश्न

- आप मेरे लिए कौन सी **प्रक्रिया** सुझाते हैं, और क्यों?
- **योनि या पेट** का रास्ता — और प्रत्येक में ठीक होने में कितना समय लगेगा?
- क्या मैं **गर्भाशय रख** सकती हूँ?
- आप **अपना ऊतक, graft या mesh** इस्तेमाल करेंगे — और जोखिम क्या हैं?
- क्या मुझे अभी **anti-leakage** प्रक्रिया चाहिए या बाद में?
- **Recurrence** की कितनी संभावना है, और वापस आए तो क्या?

### और जानने योग्य बातें

- यदि आप सर्जरी से बचना या टालना चाहती हैं, तो **पेसरी (pessary)** हमेशा एक गैर-सर्जिकल विकल्प है।
- वजन, कब्ज, खॉंसी को ठीक करना और (रजोनिवृत्ति के बाद) vaginal estrogen लेना परिणामों को बेहतर बना सकता है।

### तैयारी कैसे करें

- सभी **pre-op जाँचें** पूरी करें और दवाओं की पूरी सूची लाएँ।
- **धूम्रपान बंद** करें और घर पर सहायता की व्यवस्था करें।
- सामान्य नियम: ~6 सप्ताह तक भारी वजन उठाना और संभोग से बचें।

#### सर्जरी से पहले अपनी टीम को बताएँ यदि आप:

- **blood thinner** लेती हैं या रक्तस्राव की समस्या है
- अभी मूत्र या योनि का **संक्रमण** है
- नया पेल्विक **दर्द, रक्तस्राव, या उभार पर न भरने वाला घाव** है

### याद रखने योग्य तीन बातें

1. प्रोलैप्स सर्जरी में कई विकल्प हैं — मरम्मत बनाम बंद करना, रास्ता, गर्भाशय रखना, सपोर्ट सामग्री, और छुपे रिसाव का इलाज।
2. शायद ही कोई एक सही उत्तर हो; सबसे अच्छी योजना आपकी शारीरिक संरचना और प्राथमिकताओं से मेल खाती है।
3. मुख्य प्रश्न पूछें, और याद रखें कि पेसरी हमेशा एक गैर-सर्जिकल विकल्प है।